

Physioguide — Clínica — Diferenciales finos codo, muñeca y mano

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Documento de razonamiento para RAG: trampas frecuentes. No diagnostica. No inventar Sn/Sp.

1. LET vs C6–C7 vs TÚNEL RADIAL

- LET — C6–C7 — Túnel radial / PIN
- Dolor máximo — Epicóndilo — Cuello ± brazo — Antebrazo proximal
- Neural — No — Dermatomo, reflejo — PIN = motor extensión
- Cozen/Maudsley — Dolor óseo familiar — Puede ser positivo por carga C7 — Dolor muscular
- Acción — Carga tendinosa — Cribado cervical — No infiltrar epicóndilo a ciegas

Trampa: tratar meses de “tenis elbow” con cuello rígido y dedo medio dormido.

2. STC vs PRONADOR vs C6–C7 vs TRIGGER

- STC — Pronador — Cervical — Trigger
- Noche / sacudir — Típico — Menos clásico — Variable — No hormigueo
- Territorio — 1.º–3.º palmar — Mediano proximal, palma a veces respetada — Dermatomo — Un dedo mecánico
- Durkan/Phalen — Apoyan — Pueden ser negativos — Negativos locales — Irrelevantes
- Bloqueo A1 — No — No — No — Sí

Trampa: Phalen positivo y trigger en el mismo paciente — pueden coexistir; no fusionar diagnósticos.

3. DE QUERVAIN vs CMC vs ESCAFOIDES vs INTERSECCIÓN

- De Quervain — CMC OA — Escafoides — Intersección
- Sitio — Estiloides / 1.er comp. — Base pulgar — Tabaquera — ~4 cm proximal al Lister
- Trauma FOOSH — No típico — No — Sí !' RX — No
- WHAT/Finkelstein — Cluster — Puede doler por vecindad — Peligroso si fractura — Menos clásico
- Edad/pinza — Uso pulgar — Pinza + grind — Joven/caída — Remeros, oficinistas

Trampa: Eichhoff positivo en todo el mundo. Tabaquera = hueso hasta que se demuestre lo contrario.

4. GOLFIsta vs UCL vs CUBITAL

Lanzador: los tres pueden convivir. Orden: inestabilidad/valgo dinámico (UCL) + territorio 4.º–5.º (cubital) + carga flexora (tendón).

5. DOLOR CUBITAL DE MUÑECA — ÁRBOL CORTO

1. ¿Trauma + tabaquera? Escafoides.
 2. ¿Fóvea + press + grind? TFCC.
 3. ¿Piano-key asimétrico? DRUJ.
 4. ¿Tendón dorsal al girar? ECU.
 5. ¿Shear LT? LT.
 6. ¿Hormigueo palmar cubital? Guyon.
-

6. POP ANTERIOR vs POP POSTERIOR vs POP MEDIAL

- Anterior + hueco + hook !' bíceps distal
- Posterior + no extiende !' tríceps distal / olécranon
- Medial + lanzamiento !' UCL

No uses “contractura” como cajón de sastre.

7. DEDOS — NO CONFUNDIR

- Hormigueo nocturno 1.º–3.º !' STC (Durkan/Phalen), no trigger
 - Dedo que se traba en palma !' trigger A1
 - No flexiona IFP tras agarre !' jersey (FDP) !' médico
 - No extiende punta !' mallet !' RX
 - Pulgar en valgo (esquí) !' UCL MCP, no De Quervain
-

8. LENGUAJE OBLIGATORIO PARA LA IA

«Compatible con», «apoya el cluster», «no confirma», «cribado de cuello», «imagen si trauma/tapaquera», «derivación si rotura tendinosa o inestabilidad».

Nunca: confirmado, siempre, 95 %, sensibilidad exacta inventada.

